

医学部講義 2026.4.14

心的外傷及びストレス因関連症群 解離症群

身体症状症及び関連症群

名古屋市立大学大学院医学研究科

精神・認知・行動医学

中口 智博

1. 心的外傷及びストレス因関連症群

ここに含まれる疾患は全て、心的外傷やストレス因となる明白な状況または事件に遭遇した結果として生じるものである。このように直接の因果関係の存在に言及する診断は、DSM-5-TRにおいて他にない。

心的外傷及びストレス因関連症群

(DSM-5-TRの「神経症性障害」の下位分類に入る)

▪ **DSM-IVで不安障害に含まれていたPTSDや急性ストレス障害が、DSM-5では新しいカテゴリーとして独立。**トラウマやストレスフルな出来事に曝露されたことを診断基準に明示している一連の疾患が上記障害群として一つにまとめられた。

◆ 心的外傷及びストレス因関連症群に含まれる疾患

- ① 反応性アタッチメント症
- ② 脱抑制型対人交流症
- ③ 心的外傷後ストレス症
- ④ 急性ストレス症
- ⑤ 適応反応症
- ⑥ 遷延性悲嘆症
- ⑦ 心的外傷及びストレス因関連症、他の特定される
- ⑧ 心的外傷及びストレス因関連症、特定不能

トラウマとは？

- 定義：心的外傷を指す場合のトラウマとは「何らかの外的出来事によって急激に押し寄せる強い不安で個人の対処や防衛能力の範囲を凌駕するもの」

（Campbell:精神医学辞典）

トラウマ概念の変遷1

(災害、戦争の精神的後遺症の解釈論争)

➤ 鉄道脊髄症

鉄道事故後の精神神経症状：脊髄の震盪：**器質論**

➤ 外傷神経症

解剖学的には証明できないが微細な分子的变化があるとする**器質論**

➤ シェルショック

第一次世界大戦後の兵士の精神神経症状：恐怖や驚愕など心理的原因によるもの：**心因論**

→ヒステリー症状としての解釈

心因重視 → 二次的疾利得への着目 → **詐病説**

➤ 驚愕神経症

クレペリン：強い情緒的動揺により**精神・身体的影響が亢進した状態**

トラウマ概念の変遷 2

➤ 戦争神経症

第二次世界大戦後、**DSM I (1952)**で**重度ストレス反応**
一過性で可逆的とされた。

→ **DSM II (1968)**では**一般的な不適応反応**へ

➤ ベトナム帰還兵・第二次世界大戦従軍兵士の症状の長期遷延・ 強制収容所症候群・レイプ被害者etc

→ **DSM-III (1980)**で**単一の外傷後症候群としてのPTSD概念の提示**
再体験、回避/精神麻痺、過覚醒(**3症状クラスター**)

➤ **外傷的出来事(A基準)の定義**・急性ストレス障害の追加

(**DSM-IV**:1994)

➤ A基準の具体化、3症状クラスターから**4症状クラスター**構成

(侵入、回避、認知と気分の陰性変化、覚醒度と反応性の著しい変化)へ

(**DSM-5**:2013)

トラウマにもタイプがある

・タイプ1（単回性トラウマ）

1回だけの突発的に起きたトラウマ性の出来事の体験による。3歳以上での体験であれば、多少の歪みはあっても記憶として残る傾向あり

例） 事故、事件への遭遇、犯罪被害、災害被害など

★トラウマ関連精神障害の古い病名

鉄道脊髄症 外傷神経症 シェルショック 戦争神経症

★日本では、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、トラウマという言葉や概念が強く意識されるようになった

わが国での外傷的出来事生涯経験率

- ・自動車事故(17.9%) 命に係わる病気(19.9%)
暴力被害(38.7%) 性的被害(15.6%) 大切な人
の不慮の死(44.4%) 他者のトラウマの目撃(40.8%)
(川上ら 2010)

トラウマにもタイプがある

タイプ2（≡ 複雑性トラウマ）

★人の心の土台に悪影響

慢性的、反復的なトラウマ性の出来事に曝される
生育環境に関連することが多く、症状も長期化しやすい

例）虐待（性的・心理的虐待を含む）、ネグレクト、母子間の愛着不全、いじめなど

- ・幼少期の不遇体験は後年のPTSD発症の代表的危険因子
- ・幼少期逆境体験のある妊産婦にとって妊娠・出産は自自身の幼少期の記憶を読み覚ますものであるため、長期的な支援を視野にいったマネージメントを早期から考慮する必要がある。

複雑性トラウマ

・3歳以下での体験であれば海馬機能の未成熟により、「記憶」としてより感覚・身体記憶として残りやすく、後日、視覚や身体感覚の症状として現れることあり

★重症例は、ボーダーラインパーソナリティ症の特徴や人格交代(多重人格)が臨床上の問題となる

★このタイプのトラウマは、当初、精神医学においても十分認識されていなかったが、長い議論の末、**2018年のWHOによる国際疾病分類第11版(ICD-11)に「複雑性PTSD」が新たな診断カテゴリーとして加わった**

★複雑性のトラウマ体験をしたからといって、PTSDのタイプが複雑性になるとは限らない

心的外傷後ストレス症

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

(posttraumatic stress disorder: PTSD)

◆疾患の概念:

著しく衝撃的な出来事に遭遇することで引き起こされる

反応性の精神障害

◆ 臨床症状(先行するトラウマ体験に関連して以下の4種類の症状クラスターが生じる)

①**外傷体験の侵入症状** ★単なる想起や考えは含まない
フラッシュバック、意図しない想起、悪夢、解離性反応等

②**外傷体験に関する持続的回避**

トラウマに関連する場所や人物の回避、トラウマに関連する記憶や考え、感情の回避等★**内的&外的想起刺激を回避**

③**外傷体験に関する認知や気分の陰性の変化**

人間不信、トラウマ体験の原因や結果に対する偏った思考・認知、怒り、罪悪感の持続、社会生活からの過度な引きこもり、疎外感等

④**外傷体験に関連した覚醒度と反応性の著しい変化**

集中困難、睡眠障害、イライラ、易怒性、自己破壊的行動、過覚醒、過剰な驚愕反応等

※症状は1か月以上持続することが必要。

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

(posttraumatic stress disorder: PTSD)

DSM-5以降では、PTSDには2種類のサブタイプを規定

◆ 解離症状を伴うかどうかを特定

- ・ 現実感消失あるいは離人感が存在する
⇒ 「解離症状を伴う」

◆ 心的外傷体験から発症までの期間が半年越えか否か

- ・ 心的外傷体験から6か月以上経過して後の発症なら
⇒ 「遅延顕症型」

トラウマ体験が脳に与える病態メカニズム

- **トラウマ体験 ⇒ 扁桃体の活動亢進**
⇒ 恐怖条件付け反応
HPA軸活性化、 中脳中心灰白質活性化、
橋・結合腕傍核過活動、 橋・青斑核亢進
- **前頭前皮質の機能低下** ⇒ 「恐怖記憶」の減弱作用低下
⇒ 恐怖記憶維持
- **海馬の機能不全** ⇒ 「恐怖記憶」の減弱作用を抑制
⇒ 恐怖記憶の再生（記憶と情動が結びついている）

トラウマティックストレスの影響

- 身体の「神経系の過覚醒」(交感神経系の活性化)が引き起こされ、脅威に直面したときに**三つの基本反応(3F)**のうちのどれかが選択される
⇒ 3F: **闘争**(fighting)、**逃走**(flight)、**凍りつき**(freezing)
- 闘争や逃走が成功して解決すれば過覚醒は徐々に治まり、トラウマの悪影響は残りにくい
- **闘争も逃走もできない、あるいは失敗したとき、大脳辺縁系は副交感神経系も同時に活性化**
(アクセルとブレーキを同時に踏んだような状態)
⇒ **凍りつき**(freezing): 他覚的には麻痺・仮死状態
- 凍りつき体験者の**交感神経、副交感神経両方の過覚醒状態が慢性化すると、トリガーによってトラウマ症状が誘発されやすい**

トラウマティックストレスの影響

・ 視床下部—下垂体—副腎（HPA系）の発動

★ストレス負荷により視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンが分泌されると下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンの分泌が促進され、副腎皮質からの**コルチゾール**分泌を促進（戦闘モード）

★海馬、視床下部、下垂体にはコルチゾールと結合する受容体が存在し、コルチゾールの分泌量増大には**ネガティブフィードバック制御**がかかる

★このネガティブフィードバック制御でコルチゾールの神経細胞に対する過度な曝露を抑制 → **トラウマ反応で、この調整システムが壊れることあり**

★HPA系の機能調節異常は、海馬神経細胞の萎縮を引き起こすことや、うつ病や心的外傷後ストレス障害とも関連することが示唆されている

・ HPA軸の発動により、免疫システムの機能低下がみられる

⇒ PTSDでは、他の精神疾患に比べて自己免疫疾患の発症リスクが高い

心的外傷は心のキズ？それ以上？

- 心的外傷とは、強烈で不快なライフイベントに遭遇し、大脳皮質、大脳辺縁系、脳幹に至る脳神経系のネットワークにおいて、物事の知覚システムに負の改変が生じてしまった状態
- 心的外傷は、遺伝子発現にまで影響することがあり、PTSDでは、認知症や自己免疫疾患のリスクが高いことが知られている。
- 心的外傷は、心のキズという表現にはとどまらない大きな負荷を人間に与えている。

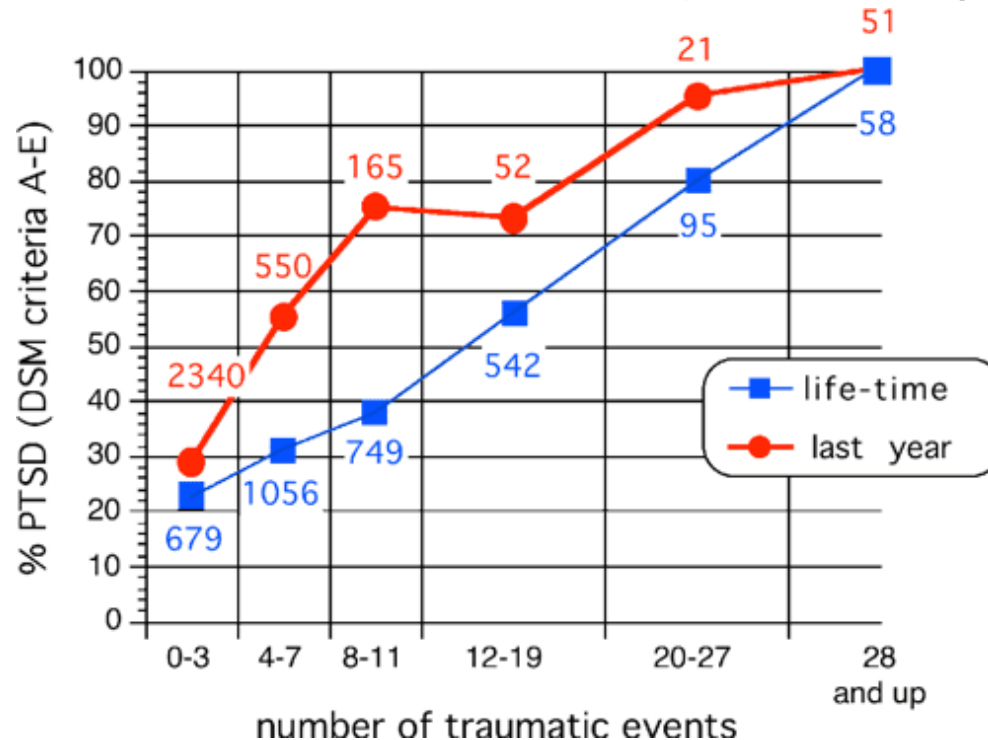
心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆疫学

- 外傷的出来事(生命や存在に強い衝撃をもたらす体験)を生涯に経験するのは男性の60.7%、女性の51.2%という報告がある。
- PTSDの有病率は一般人口の約7% (国、地域によって罹患率は異なる)
- PTSDの生涯罹患率 1.3%程度
- 外傷体験のタイプによってPTSD発症率が異なる。
(大災害で10%程度、ベトナム戦争の退役軍人では15%、性的暴力被害では6か月後に約40%)
- PTSD患者の最大50%の人々は慢性経過をたどる(3分の1というデータもある)。
- PTSD発症者の約1/3で、5年以上にわたりPTSD症状が続いている。寛解までの期間は、何らかの精神医学的な治療を受けたほうが受けない群よりも短い。
- PTSDはうつ病、睡眠障害、アルコール依存などを併発しやすい。

ビルディング・ブロック・エフェクト

- 過去に経験したトラウマ体験の増加に伴い、心的外傷後ストレス障害発症のリスクが上昇することが報告されている。



- PTSD and the “building block” effect of psychological trauma among West Nile Africans (2003)
- [M. Schauer, F. Neuner et.al](#)

物質関連症とトラウマ

- PTSDは物質関連症と密接な関連があり、同症の12－34%、女性では30－59%にPTSDが併存している
(Najavits LM, et.al. 1997)
- PTSDと物質関連症の併存症例では、解離という防衛機制で対処できない場合に、物質使用で「**化学的解離**」を人為的に起こして対処している者がいる(単に物質使用を止めると感情的苦痛が強まり自傷・自殺行動が増すリスクあり)
(Najavits LM, et.al. 2012)
- PTSDと物質関連症の併存症例はしばしば治療困難で、それぞれには有効な治療法も奏効しないことがある

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

(posttraumatic stress disorder: PTSD)

◆疾患の概念:

著しく衝撃的な出来事に遭遇することで引き起こされる
反応性の精神障害

◆臨床症状(先行するトラウマ体験に関連して以下の4種類の症状クラスターが生じる)

①**外傷体験の侵入症状** ★単なる想起や考えは含まない
フラッシュバック、意図しない想起、悪夢、解離性反応等

②**外傷体験に関する持続的回避**

トラウマに関連する場所や人物の回避、トラウマに関連する記憶や考え、感情の回避等★**内的&外的想起刺激を回避**

③**外傷体験に関する認知や気分の陰性の変化**

人間不信、トラウマ体験の原因や結果に対する偏った思考・認知、怒り、罪悪感の持続、社会生活からの過度な引きこもり、疎外感等

④**外傷体験に関連した覚醒度と反応性の著しい変化**

集中困難、睡眠障害、イライラ、易怒性、自己破壊的行動、過覚醒、過剰な驚愕反応等

※症状は1か月以上持続することが必要。

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆ 診断 (詳細な診断基準は成書を参照のこと)

- ・ 診断に直結する生物学的な検査はない
- ・ 診断基準に基づいて、丁寧な問診により診断される
- ・ PTSDの症状評価:

構造化面接法⇒CAPS

自記式質問紙⇒外傷後ストレス診断尺度(PDS:簡易診断と重症度測定).
出来事インパクト尺度(IES-R:重症度測定) など

★診断面接や質問紙で記憶に曝露すること自体が再体験症状を引き起こしてしまう可能性に留意

- ・ 災害時に一般住民に対して臨床の尺度でアセスメントすると擬陽性や過大評価につながりやすい。

★どのようなトラウマ体験にどのように曝露したのかという条件(A基準)を満たすかどうかは診断では重要

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

★**A基準(下記は6歳を超える人に適用)**: 実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来事への以下のいずれか一つ(またはそれ以上)による曝露

1. 心的外傷的出来事を直接体験する
2. 他人に起きるのを直に目撃する
3. 近親者や親友に生じたトラウマ体験を耳にする(このタイプで死ぬor危うく死にそうになる出来事の場合は暴力的、偶発的なものであることが必要)
4. トラウマ体験の強い不快感を抱く細部に繰り返しor極端に曝露される体験

例: 遺体収集の任務につく人、児童虐待に詳細に反復的に曝露される警察官

★基準A4では、仕事に関連するものでない限り、電子媒体、テレビ、映画、写真による暴露には適用されない

※6歳以下の小児のための診断基準が別にある。

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆治療の方針

実際の臨床現場では……

まずは安心感の提供、トラウマ体験と関連した場所や状況から遠ざけること、がPTSD治療の重要な第一歩

- ①トラウマ体験に焦点を当てた治療の適応の有無の判断と治療タイミングのアセスメント(無理に行うとかえって病状悪化)
- ②他に優先すべき臨床的な問題や併存症への対応
- ③物質乱用・依存の問題への介入
- ④自殺のリスク評価と安全確保
- ⑤現在進行中のトラウマ体験からの保護(DV、虐待など)
- ⑥フラッシュバック以外の精神病症状への介入
- ⑦訴訟の問題など多方面からのアセスメントに応じて現実的な治療介入を行うことになる。

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆治療の方針

- ・ ガイドラインやメタ解析では、**薬物療法はトラウマ焦点化心理療法に次いで第2選択と位置付けられる。**
- ・ 実際の現場ではエビデンスを参照しつつケースバイケースの判断が必要

以下の場面で薬物療法が重要となる

- ★トラウマ焦点化心理療法にアクセスできない場合
- ★患者さんが薬物療法を希望
- ★解離や自殺念慮が顕著などトラウマ焦点化心理療法が適さない場合
- ★重症例や難治例、ストレスが持続しているようなケース
- ★うつ病や不安障害を合併している場合
- ★興奮や衝動性、精神病症状を伴っている場合

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆治療

①薬物療法:

選択的セロトニン再取り込み阻害(SSRI)

- 我が国でPTSDの適応がとれているのは、**paroxetine**、**sertraline**の2剤のみ
- 抗うつ薬では**ベンラファキシン**の有効性も報告されている。
- SSRIはPTSD症状を改善させるが効果量0.3程度と小さい
- PTSD発症の予防効果を証明された薬剤はない。
- 薬物療法をいつ開始するか、望ましい投与期間、中止法についてもエビデンスは得られていない。
- 合併症状によっては**ミルタザピン**や非定型抗精神病薬なども有用である可能性がある。

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆治療

②心理療法

- ・**持続エクスポージャー法(PE)**: 成人向き、曝露強度強い
トラウマ体験を十分記憶しており語ることができることが条件
- ・**認知処理療法(CPT)**: トラウマ記憶の筆記は必須ではない
- ・**眼球運動による脱感作と再処理法(EMDR)**: 曝露の負担少なく宿題不要。患者負担の少ないPTSD治療法(WHOが推奨)
- ・**ナラティブ・エクスポージャー・セラピー(NET)**: 脱落率低く低
中所得国や戦争・紛争地域で実施可能性高い
- ・**トラウマ焦点化認知行動療法**(身近な養育者とともに行う)
20歳未満向き

心的外傷後ストレス症 309.81 (F43.10)

◆治療

③心理教育

PTSDという疾患について十分理解していただくことが重要。双方向のコミュニケーション、症状の外在化、ノーマライゼーション、症状の理解、飲酒や薬物乱用のデメリットについての説明、不安マネジメントのためのリラクゼーション技法教授等。家族のサポート力を高めるために、家族への心理教育も重要

参考：武蔵野大学心理臨床センター HP
トラウマ支援コンテンツ

PTSDに対する心理療法

持続エクスポージャー療法

持続エクスポージャー療法 1

- ◆PTSDに対する治療効果が証明されている
- ◆幅広いトラウマに対して実証的エビデンスあり
- ◆ E.Foaが開発した曝露療法主体の心理療法
- ◆回避をさせず、トラウマ記憶に直面化を促すことを徹底するプログラムになっている。

《トラウマの問題を遷延させる3つの要因》

- ・トラウマ関連の場面回避
- ・トラウマ関連の思考やイメージの回避
- ・非機能的な信念「私は非常に無能」
「世界は非常に危険」

持続エクスポージャー療法 2

◆治療プログラム（1回約90分、週1－2回、全8－16セッション）

- ・治療原理の説明
- ・心理教育
- ・呼吸法（呼吸がリラクセーションに関係）
- ・想像エクスポージャー（トラウマ記憶に対して）

トラウマの記憶について、情動を十分伴って、閉眼したまま現在形で語り続ける。治療の音声テープを自宅でも聞く。

- ・現実エクスポージャー（人、場所、モノ、状況、活動に段階的に向き合う）
- ・宿題あり：毎日、呼吸法、エクスポージャー

※エクスポージャーはそれぞれ30分以上

※セラピストはクライアントの勇気を認め、共感を伝え、非審判的な態度で接する。協力して作業を進める

想像および現実エクスポージャーの意義

- 想像 & 現実エクスポージャーによって、患者は**トラウマ的な出来事と、それに似ていても危険ではない出来事を区別**できるようになる
- PTSDの患者は、トラウマとなった出来事について考えるだけで、まるで被害が「まさしく今、ここで」起こっているように感じるが多いが、トラウマ記憶への想像エクスポージャーを繰り返すことで、**それを思い出し取り乱しても、再度被害を受けるわけではないと理解**できるようになる
- さらに被害の出来事について考えることは危険ではないことに気づき、**過去と現在を区別**できるようになる
- 繰り返したトラウマ記憶を物語ることで、出来事の記憶の中には様々な要素があると気づき、**必ずしも世界は危険とか自分は無力だ、と信じる必要はないと理解**できるようになる

PEの適応

- 開発者のFoa らがPE の治療対象とした患者の多くはトラウマ被害から3ヶ月以上経過していた
- 一般的には、**少なくともトラウマ被害から1ヶ月が経過し、それでもなお強い PTSD 症状が持続している患者**が適応となる
- トラウマのタイプはどのようなものでもよい
- 完全にPTSDの診断基準を満たしていなくても、明らかなPTSD症状が存在しており、苦痛や生活への障害が生じていて、**トラウマ体験を十分に記憶し、語ることができ、また切迫した自殺または他害行動ないし自傷行為の恐れがない場合に**適応となる

PTSDに対する心理療法

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

(眼球運動による脱感作と再処理法)

- ◆ PTSDに対する治療効果が立証されている心理療法
- ◆ 1989年に開発者のFrancine Shapiroが最初の論文を発表。きっかけは、目を左右に動かしていたら、自分の不安が消えたことだった
- ◆ 心理療法に眼球運動が加わった奇抜さに賛否両論があったが、センセーショナルな効果に追試が相次いで行われ、短期間でエビデンスを確立
- ◆ 認知療法、行動療法、力動的的精神療法など様々な心理療法の要素を取り入れているが、特徴的なのは、トラウマ記憶にイメージ曝露を行う際に、左右方向の眼球運動や、聴覚、触覚の左右交互刺激を加える点である

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

(眼球運動による脱感作と再処理法)

- ◆ 眼球運動や聴覚、触覚の左右交互刺激の意義について、脳科学的な研究が進みつつある。催眠療法や単なる曝露療法とは異なることが指摘されている。
- ◆ PTSDに併存する「うつ」や「不安」も軽減されることが報告されている。
- ◆ PTSDに限らず、トラウマ記憶が関与した精神症状や身体症状(慢性疼痛、幻肢痛、皮膚疾患など)の治療にも応用されている。

PTSDに対する心理療法

認知処理療法

認知処理療法(CPT)

- トラウマ体験によって生じた認知の歪みと、それらが感情や行動に与える影響を重視した心理療法
- トラウマ体験をすると、人は、以前からの既存の認知構造(スキーマ)と関連づけて出来事を意味づけようとし、通常はトラウマの情報と既存のスキーマの帳尻を合わせるために調節が働く
- その調節が不調和をきたすと、「自分のせいでこんな出来事が起きた」「世界は全て危険だ」「人間は誰も信用できない」等、偏った信念が過度に一般化されてしまうため、CPTはバランスのよい認知の回復を目指している

認知処理療法(CPT)

- 個人セッション、集団セッションの両方がある
- 個人の場合、50分/回を12セッション程度行う
- 心理教育、信念と感情の関連、回避がPTSDの病状を長引かせること等について話し合う
- トラウマが自分の信念にどのように影響を及ぼしたかについての記述(出来事の意味筆記)、ネガティブな感情や不適応な行動を引き起こして回復を妨害している役に立たない信念(スタックポイント)への焦点化等に取り組む
- 自宅での宿題あり
- 安全、信頼、力とコントロール、価値、親密さ等の領域でバランスのとれた信念を育めるように支援する

トラウマに対するボトムアップ方式の身体心理療法

- トラウマ症状の多くは、記憶、感情、情動、生理反応の問題として現れる
- 理性脳である大脳皮質からの働きかけだけでは症状のコントロールは困難
- 大脳辺縁系と脳幹を合わせた「情動脳」への介入として身体心理療法は有効である可能性がある

トラウマに対する身体心理療法

- **ソマティック・エクスペリエンス** (エビデンス 未)

トラウマ記憶に直接曝露しないで、身体感覚を追跡しながら、闘争、闘争、凍りつきの結果として滞留している身体エネルギーを解放させる

- **センサリー・モーター心理療法** (エビデンス 未)

トラウマに対する未消化の感覚運動反応の統合を促進し、認知、感情レベルの障害を解消させる。専門家の評価は高いが臨床研究はこれから

- **TFT/EFT** (エビデンス 形成途上)

経絡のツボ刺激と眼球運動をイメージ曝露を組み合わせた療法。小規模のRCTは多数出てきている。EMDRとの組み合わせも臨床現場では行われる。セルフケアとして実施できることがメリット

- **ヨーガ** (エビデンス 形成途上)

2014年にPTSDに対する最初の論文が出た。マインドフルネスや呼吸法を導入。ヨーガ20週間のプログラムで島や内側前頭前皮質の活動が増加。トラウマ反応に対する自己調整力が増す

複雜性PTSD

複雑性PTSD

- WHOによるICD-11(2018年)では、複雑性PTSDが新たな診断カテゴリーとして加えられた。
- 複雑性PTSDは、元々は、慢性反復性のトラウマ的出来事による心理的影響をとらえるために提唱された概念で、独立した診断カテゴリーにするかどうかで長年の議論があった。

複雑性PTSD：議論の流れ 1

- PTSDの概念を決定づけたのはDSM-III (1980)で、**再体験、回避、過覚醒**を三大症状とし、比較的明瞭なトラウマ体験(戦闘、レイプ被害等)の心理反応を代表していたが、これでは長期間にわたる反復性トラウマ体験による心理的影響をとらえきれていない、とHermanは主張(1992)。
- 長期反復性トラウマの例として、たとえば、人質、戦時捕虜、強制収容所生存者、宗教的カルトの生存者、DV、子供の身体的・性的虐待、性的搾取等々がある。
- 長期間にわたる反復性のトラウマ体験は、**感情制御、対人関係、自己意識**に重大な影響を与えられており、DSM-IIIのPTSDの診断基準には包摂しきれないということが、議論の大元にあった。

複雑性PTSD：議論の流れ 2

- Hermanの主張を反映して、DSM-IVの作業部会は「他に特定不能の極度ストレス障害」(disorders of extreme stress not otherwise specified: **DESNOS**)という呼称を作り、感情制御変化、意識変化、自己感覚変化、加害者への感覚の変化、他者との関係の変化、意味体系の変化、身体化の7カテゴリーによる27症状を含めた
- その後の研究で、DESNOSの診断がついた者でPTSDの診断がつかない者は8%だけだったことから、
DESNOSをPTSDとは別の診断単位にすることが難しくなり、DESNOSはPTSDの診断解説の中に、長期反復性トラウマ体験者によくみられる関連徴候として記載されるにとどまった

複雑性PTSD：議論の流れ 3

- DSM-5では、複雑性PTSDの公式診断は見送られたが、PTSDの診断基準に「認知と気分の陰性の変化」を追加したり、過覚醒症状の1つとして「無謀ないし自己破壊的な行動」を加え、DSM-IVよりはDESNOSを意識しているようにみえる
- さらにDSM-5では、「解離症状を伴うサブタイプ」がPTSD診断基準の中で新たに定義づけられた
- **ICD-11は複雑性PTSDの診断を取り入れたが、先の研究で「DESNOSの診断がついた者でPTSDの診断がつかない者は8%だけだった」ことを参照して、複雑性PTSDの診断には、PTSDの診断基準を満たしていることを前提とした**
- ICD-11の**複雑性PTSD＝PTSD＋自己組織化の障害**
(Disturbances in Self-Organization:DSO)である

複雑性PTSD：議論の流れ 4

- DSM-5は、PTSDにDESNOS的症状を一部取り込んだところで止めたが、ICD-11は、PTSD自体の症状項目を簡素にしたうえで、DESNOS的症状を全て取り込んで複雑性PTSDとした
- ICD-11のPTSDは、3症状カテゴリー6項目で構成されており、**このPTSD基準を満たしたうえで、さらにDSOの3症状カテゴリーを満たすと、複雑性PTSDの診断となる**
- DSOの各症状も当該のトラウマ的出来事と明らかに関連して生じたものでなければならない
- ICD-11のPTSD診断で定める外傷的出来事は「**極度に脅威的なあるいは恐怖となる出来事**」とされ、DSM-5の出来事基準よりもやや曖昧
- またICD-11ではPTSDの診断に必要な症状の持続期間は「**数週間**」で、DSM-5の「1か月以上」より短くても診断可能

ICD-11のPTSD診断要約(飛鳥井 2019)

- 出来事

極度に脅威的なあるいは恐怖となる出来事ないしは一連の出来事に曝露

- 症状

①**鮮明な侵入的記憶**:フラッシュバックや悪夢の形による、外傷的出来事が今起きているような再体験

②出来事に関する思考や記憶の**回避**、あるいは出来事を想起させるような活動、状況、人物の**回避**

③今も脅威が高まっているような持続的感覚で**過度の警戒心**ないしは不意の物音などに対する**過剰な驚愕反応**

- 持続時間

少なくとも数週間続いている

- 機能障害

症状により個人、家族、社会、教育、職業あるいは他の重要な機能の領域において顕著な障害を生じている

ICD-11の複雑性PTSD診断要約(飛鳥井2019)

- 出来事

極度に脅威的なあるいは恐怖となる出来事ないしは一連の出来事で、もっともよくあるのは長時間ないし繰り返された出来事で、逃れることが困難ないし不可能な出来事(例:拷問、奴隷の境遇、集団虐殺、長期のDV、子ども期に繰り返された性的ないし身体的虐待)に曝露

- 症状

PTSDの診断基準を全て満たしている

さらに以下の特徴が重篤かつ持続してみられる(DSO)

- ①**感情制御の困難**(傷つきやすい、暴力的爆発、ストレス下での遷延性解離状態、感情麻痺&喜びまたは陽性感情の欠如)
- ②**否定的自己概念**(自分自身に関する卑小感、敗北感、無価値感といった思い込み、出来事にまつわる恥、罪、失敗の感情を伴っている)
- ③**対人関係障害**(人間関係を維持することや他人に親密さを感じるものの困難)

- 機能障害

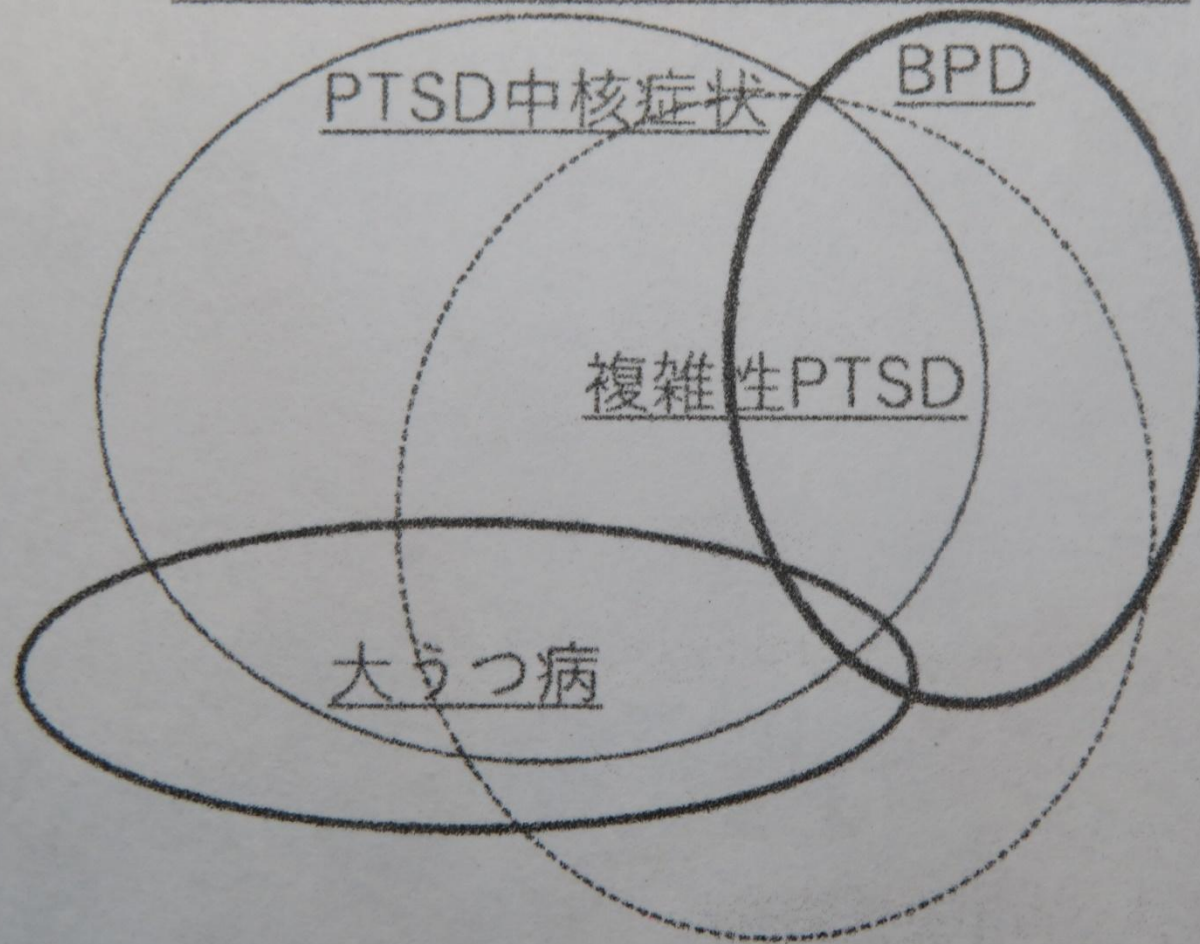
症状により個人、家族、社会、教育、職業あるいは他の重要な機能の領域において顕著な障害を生じている

PTSD,複雑性PTSDの原因となる出来事

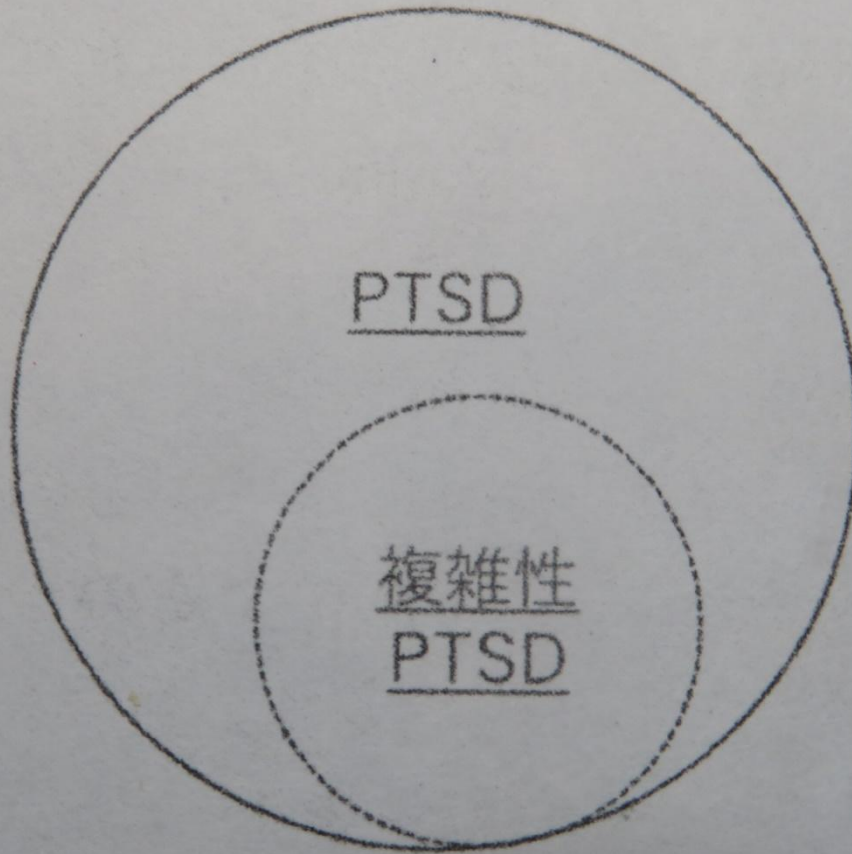
- 一般にPTSDは単回トラウマ、複雑性PTSDは長期反復性トラウマと関連付けて考えられているが、実際には、長期反復性トラウマのサバイバーの中で、複雑性PTSDではなくPTSDの症状のみ示す者が一部おられ、単回の性被害や暴力事件被害者の中に複雑性PTSDの症状を示す者が一部おられる
- 上記の相違は、個人個人の「脆弱性」や「サポート体制」など環境要因との相互作用で生じている可能性はある
- よって**長期反復性トラウマは、複雑性PTSDのリスクファクターではあるものの、そうでなければ複雑性PTSDの発症のストレッサーとはみなさない、という排他的基準となすべきではないと考えられている**

(田中 2020より引用)

従来の複雑性PTSD(Resick, 2012)



ICD-11の複雑性PTSD



(田中 2020より引用)

PTSD・複雑性PTSDの診断に関する課題

- 今後、ICD-11ではPTSDと複雑性PTSDの鑑別が求められる
- そのためには**自己組織化の障害**(DSO)の有無を正確に評価する必要がある
- また複雑性PTSDとボーダーラインパーソナリティ障害(BPD)の除外も必要
- PTSD＋BPDと複雑性PTSDの鑑別も必要になる
- ICD-11の複雑性PTSDとDSM-5のPTSD解離サブタイプは、どちらが医学的、疫学的、治療的にみて臨床で有用な診断となるのか等、様々な研究テーマを提示している

複雑性PTSDに対する精神療法

●STAIR&NST: (感情と対人調整のスキルトレーニング・ナラティブセラピー)

幼少期のトラウマによる複雑性PTSDに対する心理療法

- Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation(**STAIR**)-Narrative Therapy(**NT**)
- **STAIR-NTは幼少期の虐待サバイバーに対する介入法として開発された**
- 治療の前半(**STAIR**)では感情への気づきと感情調整スキルの学びに取り組み、引き続き、対人関係スキーマの同定と修正、アサーショントレーニング等と治療者とロールプレイで練習。
- 治療の後半(**NT**)では、PTSD症状の解消、トラウマ記憶の処理のためにナラティブワークに取り組む。NTはPEに準じるが、曝露時間はPEより短く、対人関係スキーマにつなげるのが特徴。

ボーダーラインパーソナリティ障害 (BPD) と 複雑性PTSDの相違

- ① BPD は治療者への操縦行為 manipulation を行うが、複雑性 PTSD ではそれが認められない
- ② BPD は見捨てられ不安が強く、そのためにアクティン
グアウトを生じることがあるが、複雑性 PTSD ではそれが
認められない
- ③ BPD に短期間の CBT を行くと、終結時に見捨てられ
不安が生じることがあるので、基本的には BPD にはより
長期の治療が必要となる

急性ストレス症

急性ストレス症 308.3 (F43.0)

acute stress disorder (**ASD**)

◆疾患の概念

著しく生命や存在を脅かすような出来事に遭遇することで引き起こされる急性の反応性精神障害。**再体験症状、陰性気分、解離症状、回避症状、覚醒症状**などを呈し、PTSDと臨床症状は類似している。**外傷体験から1カ月未満において診断可能**。DSM-5では、DSM-IVほどには解離症状が強調されなくなった。

—PTSDの前駆的な障害—

◆疫学・予後

- 外傷的出来事のタイプによって有病率に差がある。
- 発症率 **女性** > 男性
- 性的暴力被害 20～50%、暴行 19%、自動車事故13～21%
- ASDの診断基準を満たした人の約70～80%が受傷6カ月後の時点で、また約60～80%が受傷2年後の時点でPTSDの診断を満たしたとする報告もある。

急性ストレス症

308.3 (F43.0)

◆ 臨床症状/診断

下記の5項目(計14症状)のうち9つ以上が、PTSDと同じA基準を満たす出来事に遭遇してから3日～1カ月未満の期間持続し、社会的、職業的に機能障害を引き起こしている。

- ①**外傷体験の侵入 (4)**(フラッシュバック、意図しない想起、悪夢等)
 - ②**否定的気分 (1)**(幸福、満足、愛情などを感じることができない)
 - ③**解離症状 (2)**(現実変容感、外傷体験の重要部分の想起ができない)
 - ④**回避症状 (2)**(トラウマに関連する場所や人物の回避、トラウマに関連する記憶や考え、感情の回避等)
 - ⑤**覚醒症状 (5)**(集中困難、睡眠障害、易刺激性の行動と激しい怒り、過度の警戒心、過剰な驚愕反応等)
- ★**大きなトラウマ体験の直後に、呆然としたような感情麻痺が続くことがあり、一見冷静に見えることがある。**トラウマ体験から1カ月足らずでこのような感情麻痺が強い場合は急性ストレス症であるかもしれない。

急性ストレス症の治療 308.3 (F43.0)

◆治療

- 受傷直後にトラウマ体験の詳細を陳述してカタルシスを得る debriefingは、有効ではないことが指摘されている。
- 受傷後に**身体的、心理的に安全な環境を提供**し、安定的で支持的な医療、精神医学的ケアと評価を継続的に行うことが重要。
- **患者との治療関係を確立**し、心理教育、必要な社会資源の提供を行う。
- 上記の基盤を築いたうえで、精神療法的介入や薬物療法が適宜考慮される。

急性ストレス症 308.3 (F43.0)

- ト라우マ受傷後2－3週間以内に開始された認知行動療法は回復を早め、PTSDへの発展を阻害し得るとされる。
- ASDの薬物療法はPTSDと同列に扱われることが多いが、ASD単独に関する薬物療法のエビデンスは限定的。その前提の中でSSRIは選択肢として考慮される。ベンゾジアゼピンはPTSD症状そのものへの効果は確立されていないが強い不安に短期使用も考慮。

重 要

- PTSDのA基準を満たさないトラウマ体験でもトラウマ関連症状は出現する
- PTSDの診断がつかなくても、トラウマ関連症状は臨床現場では無視できない大きな問題
- **トラウマ関連症状は、様々な精神疾患に併存したり背景に隠れていたりする**

精神疾患におけるトラウマの影響

精神病とトラウマ 1

- トラウマは、統合失調症などの精神病と関連することが指摘されている。
- 子供時代に不遇体験がある場合は、ない場合よりも精神病に罹患する可能性が2.8倍高くなる
(Varese F. et al. 2012)
- 子供時代の不遇体験やトラウマと、精神病罹患や精神病症状との間には量一反応関係が認められる
(Shevlin M. et al. 2008 2011)
- トラウマ体験に対する反応として精神病とPTSDがスペクトラムを構成するという見方がある
(Morrison AP. et al. 2003)

精神病とトラウマ 2

- 精神病におけるトラウマやPTSDは、臨床現場では過小評価されやすい
- 精神病の診断がつくと、幻覚や妄想など精神病症状や現在の機能レベルの評価等に臨床家の関心が集中して、トラウマの問題が考慮されにくくなる
- 精神病患者のトラウマを取り扱うことで、かえって病状が悪化するのではないかと考える医療者が少ない

精神病とトラウマ 3

◆精神病性障害に併存したPTSDに対する介入研究(ランダム化比較試験)

- **PE**群(53人)vs **EMDR**群(55人)vs 待機群(47人)
★赤字はPTSDの治療法としてエビデンスのある心理療法
- 治療期間中にPTSDの診断を満たさなくなった割合
PE群(56.6%) EMDR群(60%) 待機群(27.7%)
- 治療効果は6か月後も維持
- 治療した両群は待機群よりも精神症状の悪化は少なく、被害的思考が改善し、精神病症状が寛解した割合が高かった
- PE群では、うつ症状の改善も認めた

(de Bont PA. et al. 2016)

うつ病とトラウマ

- DSM-5以降のPTSDの診断基準には、**認知と気分の陰性変化**が含まれており、トラウマに対する反応としてうつ状態が現れることは珍しくない
- うつ病の治療中に、(うつ症状との関連を患者も治療者も認識していなかった)トラウマ体験が浮上することがある (**患者さんがトラウマを意識しても治療者に黙っていることもある**)
- うつ病治療中にトラウマの問題に直接介入するかどうかには慎重な判断が必要
- トラウマ治療を行ってうつ病が改善することもあるが、トラウマ治療が患者のうつ症状を悪化させる懸念がある場合や、トラウマに触れることを患者が拒否しているときは、心理教育程度にとどめる

不安症とトラウマ 1

トラウマ症状	関連が深い不安障害
再体験症状	(パニック症)
回避症状	社交不安症 広場恐怖症 (分離不安症)
認知・気分症状	社交不安症
過覚醒症状	パニック症 全般性不安症 (分離不安症)

不安症とトラウマ 2

- パニック症や全般性不安症など不安症だけでは説明しづらい認知の偏りや社会機能の低下があれば、何らかのトラウマの影響を疑うべき
- 全般性不安症では症状が常態化しているので、自我違和感が低下していることが多く、これは慢性化したPTSDで覚醒亢進状態が主に残存している病態と似ている
- 子供が保護者から離れることに激しく抗うことが突然生じるようなときには何らかのトラウマ体験の存在を疑う
- トラウマ症状の中で、否定的認知や孤立感が強いケースは社交不安症の病態とかぶりやすく、強い恥辱感を有する社交不安症の中には性被害や虐待のトラウマを抱えているケースがある

強迫症とトラウマ 1

- 児童強迫症患者は健常児と較べて発症前1年以内により多くのライフイベントを体験
- トラウマ的体験が強迫症発症の直接的なきっかけになるケースの多くは若年男性で、汚染・洗淨の症状を呈しやすい
- 教師や上司からの叱責で嫌悪感を抱き、相手が触れたものが汚染恐怖の対象となるパターンも少なくない
- 強迫症患者におけるPTSDの併存率は2割弱
(Fontenelle LF, et al. 2012)
- トラウマ体験後発症の強迫症は、発症年齢が遅く、加害、性的、宗教性、「ためこみ」の強迫タイプが多く、気分障害や不安症などの併存率が高い (Fontenelle LF, et al. 2012)

強迫症とトラウマ 2

- 強迫症発症とストレスフルなライフイベントとの関連調査で、6割の患者がそのようなイベントを経験しており、女性、急性発症、身体的強迫観念と強い関連性がある (Rosso G, et al. 2012)
- 本邦での調査では、女性は家庭・妊娠出産に関すること、男性は転職・配置転換等、職業関連のライフイベントが強迫症発症前1年以内に先行している傾向がみられた (富田ら. 2007)
- 強烈なライフイベントで条件づけられた不安や恐怖は、強迫行為によって強化される (中尾 2018)

精神科臨床とトラウマ (青木ら 2018)

トラウマが潜んでいると……

- 病状が非定型で従来診断と鑑別が困難になる場合がある
- トラウマ関連症状に気づきにくいことがある
- トラウマ関連症状はそのときの環境で変動する
- 治療者や支援者との関係が安定しない

<重要ポイント>

明確に示されないトラウマは、PTSDの診断はつかなくても病状に大きな影響を与えていることがある。病態把握にトラウマの視点を加えることは、患者が示している病状の理解を深めることに役立つ場合がある

適応反応症

適応反応症

◆疾患の概念

- 一つ以上のストレスとなる出来事や生活環境上の変化など、明らかな心理社会的ストレスに対する反応としての感情面または行動面の症状を指す。ストレスの質や強さについては定められていない(**PTSDのA基準のようなものはない**)。そのストレスに対する反応として通常予測される程度を超えて支障が出たり苦痛が大きい場合に該当する。
- ストレスの発現から3カ月以内に発症し、ストレスの解消から6カ月以内に症状が消退すると提唱される。
- **DSM-5以降では、正常な死別反応は適応反応症に含めない**。

適応反応症

◆疫学

- ・一般人口における疫学研究は乏しい。**身体疾患患者での割合は高く**、精神科コンサルテーションを受けた総合病院入院患者の12%が該当との報告あり
- ・乳がん再発患者では35%という報告もある
- ・自然災害被害者や従軍兵士においても高い有病率
- ・**女性**は男性の2倍という報告あり

◆症状

- ・うつ病には至らない抑うつ気分
- ・不安症群には至らない不安症状
- ・仕事や家事ができない等の役割遂行困難（素行障害）
- ・上記の抑うつ気分、不安、素行の障害などの組み合わせでサブタイプを構成

★A基準を満たさないだけのPTSD様症状や、A基準を満たすがPTSDの症状を部分的にしか満たさないケースもここに該当

適応反応症

◆ 予後

- ・成人例では、適切な治療で予後は比較的良好とされる。
- ・児童青年期例では成人例よりも回復に時間がかかる。
- ・児童青年期例の10年予後調査で、経過良好であったのは44～60%程度。経過不良例には統合失調症、躁うつ病、うつ病、物質依存などが認められた。

◆ 治療

- ・**薬物療法は症状に応じて行われる補助的なもので、SSRIはよく使用される。**
- ・**精神療法が治療の中心**で、支持的精神療法、認知行動療法、力動的な精神療法、ストレス対処指導、環境調整の助言などが行われる。

遷延性悲嘆症

遷延性悲嘆症

◆診断

- A. 少なくとも12か月前（児童、青少年では、少なくとも6か月前）
の、悲嘆する者に親しかった人の死（注：**長いことを指している**）
- B. その死以来、以下の症状の1つまたは両方が毎日みられることを特徴とする。持続的悲嘆反応の出現、さらに、その症状は少なくとも過去1か月間、ほぼ毎日おきている

（1）**故人への強い思慕、あこがれ**

（2）**故人についての思考、記憶にとらわれている**（児童および青年では、そのとらわれは死の状況に集中しているかもしれない）

遷延性悲嘆症

C. その死以来、次の症状の少なくとも3つが、ほとんど毎日、存在している。さらに、これらの症状は少なくとも過去1か月間、ほぼ毎日起きている

- (1) その死以来、**同一性の破綻**(例: 自分の一部が死んだような感覚)
- (2) **その死が信じられないという強い感覚**
- (3) **その人が死んでいることを思い出させるものからの回避**(児童および青年では、思い出させるものを避けようとする努力によって特徴づけられるかもしれない)
- (4) その死に関連した**激しい情動的苦痛**(例: 怒り、恨み、悲しみ)
- (5) その死以来、**対人関係や活動を再開することの困難**(例: 友人と関わること、興味を追求すること、将来の計画を立てることなどの問題)
- (6) その死の結果、**情動が麻痺する**(情動的体験の欠如または著しい減少)
- (7) その死の結果、**人生が無意味であると感じる**
- (8) その死の結果、**強い孤独感を感じる**

遷延性悲嘆症

D. その障害は臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている

E. その死別反応の持続期間と重症度は、その人の文化や状況に対して期待される社会的、文化的、または宗教的な基準を明らかに超えている。

F. その症状は、うつ病や心的外傷後ストレス症などの他の精神疾患によってうまく説明されるものではなく、物質（例：医薬品、アルコール）または他の医学的状態の生理学的作用によるものでもない。

遷延性悲嘆症

◆急性期の悲嘆が長引き、心身に有害な影響をもたらし社会生活機能が障害される状態は、これまで「**複雑性悲嘆**」と呼ばれてきたが、ICD-11やDSM-5-TRの中で遷延性悲嘆症として精神疾患に位置付けられた

◆この病態では、しばしば自己に関する**不適応的認知**、故人の死に関する**罪悪感**、自分の将来の**余命や人生の目標の縮小**を経験

◆身体愁訴がこの状態に伴いやすく、併存する抑うつや不安、社会的同一性の破綻、および医療機関への受診の増加に関連することがある

◆身体症状は、故人が経験したこと(例：食欲の変化)と関連していることがある

◆自己管理や気配りの低下に関連した健康に有害な行動もまた、この病態にはよくみられる

◆この病態の他の関連する特徴として、恨み、怒り、または落ち着きのなさ、その死を他人のせいにする事、および睡眠の量と質の低下がある

遷延性悲嘆症

＜治療＞

◆薬物療法では十分な有効性が示されておらず、複数のメタアナリシスで、心理療法、特に悲嘆に焦点化した認知行動療法の有効性が報告されている。

小児のストレス因関連症

小児のストレス因関連症

アタッチメント(愛着)とは、小児期早期にある特定の他者との関係によって形成される**情緒的絆**(Bowlby)を指す。保護を受ける中でのスキンシップや情緒的交流によって自己の存在を受け入れられているという安心感と自己肯定感が醸成され、安定した対人関係の基盤となる**基本的信頼感**(Erikson)が獲得される。

反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症は、乳幼児期に特定の母性的存在によって十分な世話や養育を与えられていないことの結果として生じる障害と考えられている。

- ◆親との死別、親との長期にわたる分離
- ◆社会的ネグレクトなど親による不適切な養育
- ◆施設養護において養育者に対して子供の比率が高い環境
- ◆里親制度で養育者が頻回に変更される

反応性アタッチメント症

313.89(F94.1)

◆疾患の概念(養育者に愛着行動を示さない)

- 極端に制限されたアタッチメント行動が特徴
- 困難な場面でも養育者に対して慰めや援助、身体的・感情的な世話、保護を求める努力をしない
- 養育者との関わりの中でも陽性の感情が表現されにくく、陰性の感情も容易には表現されない
- 自閉スペクトラム症との鑑別が必要
- 虐待との関連からPTSDや解離症などを合併することあり
- 抑うつ気分との関連あり
- 適切な療育に反応する
- **診断可能な年齢を9ヶ月～5歳以前と規定(DSM-5)**

◆疫学

養育施設で育った4歳半の児童の約15%程度

脱抑制型対人交流症

313.89(94.2)

◆疾患の概念

- 見慣れない大人に対してためらいなく近づき、過度に馴れ馴れしく振舞う
- 不慣れな状況でも、大人の養育者を振り返って確認することも乏しい
- 不注意、過活動と関連あり
- 注意欠如多動症(ADHD)との鑑別が必要であるが、本障害では、注意集中の困難さや多動は示さない
- 虐待との関連からPTSDや解離症などを合併することあり
- 抑うつ気分とは関連なし
- 適切な養育には部分的に反応するか、または反応しない

◆疫学

重度のネグレクトにさらされ施設に入るような母集団で20%程度

反応性アタッチメント症・脱抑制型対人交流症 の治療方針

- 身体的・性的虐待の被害の有無、養育者の問題、経済的な問題、家族の社会的状況など詳細なアセスメントを行う
- 子供の安全確保、保護的環境下での治療的な子育てをしつつ、愛着の再形成を阻害するトラウマの処理等を含めて精神療法による愛着の再形成、間違った愛着の修正を促す
- 親への支援や養育環境の整備も考慮するが、再統合を目標とすべきではない「治療不能な家族」もある
- 我が国では、上記二障害に適応のある薬物はない。臨床像に応じて、適応外使用されることはある
- 精神科治療のみで治癒は困難で、多職種によるチームとしての支援が必要

2. 解離症群

解離症群

- 解離症の特徴は、通常よく統合されているはずの自我、記憶、意識が混乱し変調すること。
- 解離はスペクトラムに沿って現れ、軽症の解離は珍しいことではない(白昼夢)。しかし、一部の人では、解離プロセスが歪むことで正常な精神生活が妨害されてしまう。
- 解離症状は一般的に、状況依存的に出現し、変遷しやすい。
- 希死念慮に解離性向が加わると自殺の危険率は増大する。
- 腫瘍、側頭葉てんかんなど、身体的原疾患が健忘、解離、離人感、現実感消失症の原因ではないことを確実に除外診断すること。

解離症群

◆特徴： 意識、記憶、同一性、情動、知覚、身体表象、運動制御、行動の正常な統合における破綻および/または不連続

→ かみくだくと・・・

トラウマや解決困難な心理的葛藤にさらされた場合に、それらに関連した観念、情動、記憶を切り離してしまうことで**直面化を避ける無意識の防衛機序（解離）**のために生じる障害。

結果として心理的苦痛を軽減、消失できるメリットが**一次疾病利得**症状による補償、学校や職場から逃げられるなど本人にとって好ましい効果は**二次疾病利得**。

心的外傷による解離現象の推移(van der Kolk)

➤一次解離

圧倒的な恐怖のために知覚を統合できなかった自我状態を指す。ここでは、トラウマ体験は視覚、嗅覚、聴覚、運動覚、感情状態などにバラバラに断片化されてしまい、体験全体を一つの体験として想起し語ることができない。(例: 交通事故後の記憶が断片的)

➤二次解離

行動の主体としての自我とそれを観察する自我の分離を指す

体外離脱体験、離人症、現実感覚喪失が生じ、トラウマ体験を外部の観察者として経験することで、本来、自我が感じる苦痛を軽減する
(トラウマ周辺期の解離)。

➤三次解離

トラウマ体験の記憶を担うために別の自我状態、つまり本来のその人と異なる認知、感情、行動様式を持つ自我状態が形成されることを指す。特定の記憶を、ある自我状態は保持していて、別の自我状態は保持していないということが生じ、トラウマ体験の記憶を切り離れた自我状態は日常生活を過ごしやすくなる。**個々の自我状態が完全な同一性を獲得すると解離性同一症(多重人格)の状態となる。**

解離症群(DSM-5)に含まれる障害

- 解離性同一症
- 解離性健忘(解離性とん走も包摂)
- 離人感・現実感消失症
- 解離症、他の特定される
- 解離症、特定不能

解離症群の診断ツール

◆ Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociation Disorder (SCID-D)

中核症状を、①健忘②離人症③現実感喪失④同一性変容
⑤同一性混乱 として、それらの重症度を評価

◆ 解離性体験尺度(DES): 28問の自記式質問紙

・DESから病的レベルを示唆する8項目だけ抽出したDES-Tは有用

DES-T

- ①気がつくと別の場所において、どうしてそこまで行ったのか自分でもわからない。
- ②自分の持ち物の中に新しい品物がある。しかし自分で買った覚えがない。
- ③自分の近くに立っていたり、自分が何かをするのを眺めていたりして、まるで他人を見るように自分を外から見ている。
- ④友達や家族の見分けがつけられない時がある。
- ⑤周囲の人間、事物、出来事が現実でないように感じる。
- ⑥自分の体が自分のものではないと感じる時がある。
- ⑦場所が変わるとまったく別の行動をするので、自分が二人いるように感じてしまう。
- ⑧何かするように命令したり、自分の行為を批判する声が、頭の中から聞こえる。

※何%の割合でそのようなことが起きますか？

解離性同一症 300.14(F44.81)

◆症状(多重人格、二重人格、交代人格)

- 2つ以上のはっきりと区別される人格が同一の個体内に存在し、時々に入れ替わって出現する(治療者が直接観察できなくても他の人の観察でも診断可)
- それぞれの人格は独立していて、名前や性格、趣味などが異なる。**交代人格の性別が個体の生物学的な性と異なることもある。**
- 通常の物忘れでは説明できないような想起困難を伴う。
- 強いストレスや小児期の被虐待が影響している場合がある。
- DSM-5では憑依体験も含む。
- **幻聴、幻視**、自発的なトランス状態、離人症状、現実感喪失、身体症状など多彩な解離症状を呈する場合、本症である可能性大
- 自殺のリスクが高い

◆疫学・ 成人の12カ月有病率は1.5%(男性1.6%、女性1.4%)

- 精神科の入院患者・外来患者での有病率は5-15%

解離性同一症 300.14(F44.81)

- 解離性同一症の診断を受ける患者の性別：**女**＞男
- 多くは慢性に経過
- PTSD同様、解離性同一症の患者の海馬と扁桃体の体積の減少が報告されている。
- 解離性同一症の患者は、他の精神疾患の診断基準を満たすことが少なくない。身体症状症、境界性パーソナリティ障害、統合失調症etc
- 解離性同一症に対する標準的な治療はないが、トラウマ治療、催眠療法などを組み合わせた長期の個人精神療法によって、交代人格が統合されて、良好な転帰をたどることもある。
- 解離性同一症の中核症状に対して薬物療法は無効であるが、うつ病や不安症の併存も多いため、それらの併存症には薬物療法の効果が期待できる。

解離性同一症の幻聴の特徴

- 解離性同一症の患者は「声」が耳からではなく、頭の中から聞こえてくると言うことがある。その「声」は気分の変調と関連なく、また通常病識を持つとされる。
- 解離性同一症に生じる幻聴は、知覚ではなく、心の中に生じる幻覚のような表象であり、「偽幻覚」とでも言うべきものではないかという意見がある。
- 対照的に、精神病患者の幻聴は「外界から来る」とされ、知覚としての性質があると言い、さらに気分の変調を伴うとされる。また病識は通常、欠如している。

解離性健忘 300.12(F44.0)

◆症状（**選択的健忘**、同一性と生活史の**全般的健忘**）

- 通常の物忘れで説明できない、自伝的情報（氏名を思い出せないことも）、トラウマ的な、ストレスフルな出来事の想起不能
- 全般性の健忘は、通常、突然生じる
- 一見目的を持った旅行や当ての無い放浪が、同一性や自伝的情報の健忘を伴う場合がある→「解離性遁走を伴う」と付記
- 解離性健忘の鑑別診断には薬物の影響、脳腫瘍、頭部外傷、認知症など様々な身体疾患、神経疾患が含まれる。
- 確立された治療法はなく、自然と回復することもある。背景のストレス状況が解決されないと、健忘や遁走の再発も有り得る。
- 催眠療法による記憶の回復が報告されているが、その後のケアや健康な対処法の強化に役立つ援助が必要。

◆疫学

- 成人の12カ月有病率は1.8%（男性1.0%、女性2.6%）
- 急激に治る場合と長期間に及ぶ場合がある。
- 寛解した後に、PTSDや自殺行動に注意。

離人感・現実感消失症

300.6(F48.1)

◆症状

あたかも外部の傍観者になったかのように自身と自身の周囲から隔絶されているという感覚を特徴とする

- 離人感または現実感の消失、またその両方の持続的または反復的な体験（意識に関する知覚の統合障害）。しかし**現実検討能力は保たれている**。
- 馴染みのなさ
- 作用主体としての実感のなさ、
- 自己所属感のなさ
- 自己分割（この世界に関与している部分とそれを観察する部分に分かれる → 自分をいつも上から見ている（**体外離脱体験**）
- 統合失調症、うつ病、パニック症、恐怖症、強迫症、薬物乱用、複雑部分発作、片頭痛、断眠、薬剤の影響などを除外する必要あり。

離人感・現実感消失症 300.6(F48.1)

◆疫学

- 正常人でも一過性の軽い離人感を体験することはある(断眠、未知の土地への旅行等)。
- 成人の12カ月有病率は2%(男女比1:1)
- 平均発症年齢は10代後半、20歳以上の発症は20%以下
- 幼少期の性的虐待は、解離症群の中では本症で一番割合が低く、学校での重度の被いじめ体験の割合は本症が最も高い。

◆治療

- **標準的治療はない。**ベンゾジアゼピン系薬剤は合併する不安の軽減に役立つ場合がある。
- 催眠、認知行動療法が、離人感、現実感消失エピソードのコントロールに役立つという報告がある。

解離性障害は統合失調症に誤診されやすい

- Schneiderの一級症状のうち、妄想知覚や物理的身体被影響体験（電磁波など）は統合失調症の病態にかなり特異的であるが、幻声、考想伝播、させられ体験等は、解離性障害においても生じることがある
- 両者は症候の類似性のために鑑別困難な場合があり、解離性障害が統合失調症と誤診されることがしばしばあり注意を要する
- 解離では、他者が自己の延長として現れ、他者と自己の区別が困難な構造を持つが、統合失調症では他者は自己と明瞭に区別され、「生（なま）の他者性」を持っている
- たとえば解離の幻声は自分の声であるかのように感じていることが多い。幻声と自分の思考との間に連続性がみられやすいのが解離の特徴
- 両者の鑑別には、生活史、病前生活の違いを見出すことが重要

解離症群の治療 1

- 解離症状以外の障害と解離症状のどちらが主でどちらが従なのかを見定めてから治療方針を立てる。
- 解離症群の治療では、基本的に薬物療法は補助的で精神療法が主体となる(解離症群に有効と実証された薬物はない)
- 解離による内服アドヒアランス不良のリスクがあるため、薬の管理を家族にまかせるほうが安全。疾患教育も重要。
- 症状自体が自己防衛機制として生じているため、患者は症状に無関心(満ち足りた無関心)であることが多く、症状の改善、消失を治療目標にすることが困難な場合が少なくない。

解離症群の治療 2

- 症状自体に焦点を当て過ぎず、患者のストレスがどこにあるのか、症状発現の契機がどこにあるのか等を共に検討し、患者のペースで自然に自覚できていくのが理想的。
- 治療者が、患者の症状に及び腰にならずに患者の安心できる場所として機能できることは重要。治療者が腰を据えて患者と関わる覚悟を持つことが効果的に働く。
- 特に解離性同一症については、構造化された精神療法的アプローチが幾つか案出されている。

3. 身体症状症及び関連症群

医学的検査によっても解決されない
身体症状によって特徴づけられる精神障害

臨床的に意味のある苦痛、生活への支障がある
健康への懸念が全てに優先されることが特徴的

身体症状症及び関連症群

(DSM-5の「神経症性障害」の下位分類に含まれる)

- ◆特徴： 医学的に説明できない身体症状(＝身体化症状)であるか否かに重点をおかず、一般身体疾患があっても、身体症状に対して重篤に考えていたり、症状に対する不安が強かったり、長時間にわたって症状にとらわれたりしている場合にも診断される。

- ◆身体症状症および関連症群(DSM-5-TR)に含まれる障害
 - 身体症状症
 - 病気不安症
 - 機能性神経学的症状症(変換症)
 - 他の医学的状态に影響を及ぼす心理的要因
 - 作為症
 - 身体症状症及び関連症、他の特定される
 - 身体症状症及び関連症、特定不能

身体症状症 300.82(F45.1)

◆特徴・症状

- 従来の「**身体化障害**」「**鑑別不能の身体表現性障害**」「**疼痛性障害**」と「**心気症の一部**」を包含
- 「**身体化障害**」とは、30歳以前に生じた疼痛、胃腸症状、性的症状、偽神経学的症状など様々な身体症状が何年も続くが、身体疾患や薬物による原因では十分に説明できない状態
- 「**疼痛性障害**」とは、痛みを説明するのに十分な身体的異常がないのに重篤な痛みが続くもの。心理的葛藤との関連あり。
- 一つ以上の身体症状のために苦痛を感じているか、日常生活を妨害され、その身体症状や健康不安に関連した不釣り合いで持続的な心配があり、その症状や健康に関する不安レベルがいつも高い、あるいは身体症状や健康不安に向ける時間やエネルギーが過剰
- 患者が訴える身体症状は概ね6カ月以上持続。一つの症状が持続している必要はなく、とらわれ懸念する症状が別の症状に移り変わることも珍しくない。

身体症状症 300.82(F45.1)

◆疫学

- DSM-IVの身体表現性障害の有病率は5～7%
- 男性<女性
- 小児では、繰り返す腹痛、頭痛、倦怠感、嘔気が最も多い
- 高齢者、失業者、性的虐待や小児虐待の既往がある者、慢性身体疾患や精神疾患の罹患者、社会的ストレスの強い者、疾病利得などの強化因子がある者などに多い
- プライマリケア場面での30%は医学的に説明不能な症状を訴え、その多くが身体症状症によるものとされる

身体症状症 300.82(F45.1)

◆鑑別診断

パニック症、うつ病、統合失調症等

◆治療(まず害をなすなかれ)

- ・ 薬物療法(SNRIなど抗うつ薬)が奏効することがある
- ・ ベンゾジアゼピン系薬剤は安易に処方しない
- ・ 標的症状を明確にして、多剤併用療法にならないように注意
- ・ 認知行動療法や森田療法が有効な場合もある(症状への関心から人生の価値や、日々の行動への関心に転換を促進)

病気不安症 300.7(F45.21)

◆特徴・症状

- ・ 以前の「心気症」のうち、ほぼ身体症状がないか軽いタイプのものを包含
- ・ **6カ月以上におよぶ、「重篤な疾患に罹患している」というとらわれや先入観が特徴。**多くは数年も持続する。
- ・ そのとらわれは通常よりも過剰で不釣り合いなレベルとされる
- ・ 結果的に**ドクターショッピング**を繰り返すことにもなる。
- ・ 患者は**アルコールや薬物の依存を併発するリスクが高い。**
- ・ 絶えざる心配は家族の負担となり、夫婦や家庭の不和に至ることもある

◆疫学

- ・ 以前の「心気症」としての有病率は1～5%。性差はあまりない。
- ・ 成人早期の20－30歳代、中年に発症しやすい。
- ・ 約50%が5年後に有意な改善を示す。
- ・ 急性発症、経過が短いほど予後良好。

◆治療

- ・ 根気よい支持的精神療法、必要に応じて抗うつ薬など。

機能性神経学的症状症(変換症) 300.11

◆特徴・症状

- 随意運動機能あるいは感覚機能の変化を示唆させる症状が1つ以上あり、著しい苦痛、機能障害を引き起こしている
 - 症状と示唆される疾患との間に臨床所見上の不一致あり
 - 変換症状は、通常の生理学的規則ではなく、患者の信じる「病気概念」に従う。
 - 後弓反張、けいれん、四肢まひや脱力、運動失調、失立、失声、視力、聴力の低下・消失、感覚鈍麻、感覚脱失等
 - ストレス因子を特定できていなくても診断可能
- ★ 主な症状が痛みに限定される場合は、変換症ではなく、身体症状症と診断される。

機能的神経学的症状症(変換症) 300.11

◆疫学

- 神経内科に紹介された患者の約5%に認められた
- 非けいれん性の発作では30歳代、運動症状では40歳代にピーク
- **発症年齢が若く、経過が短いほど予後良好**
- 急性発症の変換症の自然寛解率は高い
- 変換症には気分障害、身体症状症、精神病性障害などの精神疾患の既往歴があることが多い
- **変換症は、発症時や症状頻発期に離人症や解離性健忘などを併存することが多い**
- 脳外傷の患者も変換症が高率に生じる(てんかん、脳腫瘍、脳卒中などの既往を有する群に多かった)

- ## ◆治療:環境調整、支持的精神療法、行動変容技法、必要に応じて抗うつ薬など

機能性神経学的症状症(変換症)

➤ 変換症は解離性障害か？

英国のBrownらは、偽神経学的症状(変換症状)と、それ以外の解離性症状とは同一症例に出現することが多いうえに、ともに心的外傷との関連が深いことから、両者は共通の基盤をもった病態であることが想定され、偽神経学的症状は解離性障害として扱われるべきだと主張

作為症 300.19(F68.10)

◆特徴・症状

- 身体的または心理的な徴候・症状のねつ造、あるいは偽りの病
気あるいは怪我を引き起こすのが特徴
- そのための治療を自分や他者に対して求める
- 特に何らかの外的な報酬や利得はない

◆疫学

- 入院患者の約1%が診断基準を満たす
- 発症は通常成人期早期

★自分自身を病人に仕立て上げるのが、**ミュンヒハウゼン症候群**

★他人を病人に仕立てあげるのが、**代理ミュンヒハウゼン症候群**

児童虐待の一部にこの病態のものが混じっているとされる

ご清聴ありがとうございました。